

ผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี

Effects of the knowledge management program on palliative nursing care among
professional nurses at Phan Thong Hospital in Chonburi Province

วัชรลีโอนาม

Wacharee Luenarm

หน่วยงานวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี

Research and Development Department, Phan Thong Hospital, Chonburi Province

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 36 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการจัดการความรู้แบบวัดความรู้ และแบบประเมินการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วย หาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบวัดความรู้ได้ค่า KR-20 เท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบที่ผลการวิจัย พบว่า 1) หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ พยาบาลวิชาชีพมีความรู้เรื่องการพยาบาลแบบประคับประคองมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ ($t = -19.394$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ พยาบาลวิชาชีพได้บันทึกการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ ($t = -11.078$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ: โปรแกรมการจัดการความรู้, การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, พยาบาลวิชาชีพ

สาธารณะจะได้รับจากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 5) วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับความตายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ 6) ความเข้าใจผิดเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เช่น เข้าใจว่าเป็นการดูแลเฉพาะกลุ่มมะเร็ง และ 7) ความเข้าใจผิดเรื่องการใช้กลุ่มยาระงับปวดว่าจะยิ่งเพิ่มความรุนแรง (ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และปาริชาติ เพ็ญสุพรรณ, 2559) ผลการศึกษาในปี 2556 จาก 234 ประเทศ พบว่ามีเพียง 20 ประเทศเท่านั้นที่มีระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และมี 121 ประเทศในโลกที่มียาระงับอาการปวดไม่เพียงพอแม้แต่จะให้บริการขั้นพื้นฐาน(Lynch et al., 2013) ดังนั้น นโยบายด้านสาธารณสุขต้องรองรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กำหนดโครงสร้างการดูแลแบบประคับประคอง จัดอบรมสร้างทรัพยากรบุคคลให้มากขึ้น ออกนโยบายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มยาบรรเทาอาการปวด

โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี มีผู้ป่วยแบบประคับประคองรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ใน พ.ศ. 2562-2566 มีจำนวน 110, 140, 146, 150 และ 251 ราย แม้ได้มีการนำความรู้มาออกแบบระบบงานเพื่อนำไปใช้วางแผนการดูแลผู้ป่วยและการตัดสินใจเลือกการรักษาแบบประคับประคอง แต่ปัญหาที่ผ่านมา พบว่า 1) ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ไม่รู้สึกตัวไม่สามารถประเมินความต้องการได้เอง ทำได้เพียงร้อยละ 13.6 2) พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย ไม่มีความรู้และความเข้าใจ มีผู้ที่ผ่านการอบรมเพียง ร้อยละ 6.1 3) ข้อจำกัดเรื่องระเบียบราชการในการยืมอุปกรณ์ 4) ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในชุมชน และ 5) ไม่มีแนวทางการบริหารยาบรรเทาอาการที่ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาลดปวดระดับรุนแรง(strong opioid) ปี 2562-2566 มีเพียงร้อยละ 11.1, 11.7, 14.3, 14.17 และ 19.9 (โรงพยาบาลพานทอง งานเวชสถิติ, 2566) พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาให้พยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความชำนาญทางการพยาบาลผู้ป่วยแบบ

ประคับประคองเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานครอบคลุมทุกมิติสุขภาพได้เพิ่มมากขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้ คือ " การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน " (กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี, ม.ป.ป.) ผู้วิจัยจึงสนใจนำแนวคิดของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนนี้ ไปใช้ในการสร้างโปรแกรมการจัดการความรู้และนำไปใช้ในการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (2563) โดยประเมินการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพจากการบันทึกทางการพยาบาลในเวชระเบียนของผู้ป่วยซึ่งเป็นการบันทึกสิ่งที่พยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบัติต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมายและใช้ในการสื่อสารกับทีมสุขภาพในการปฏิบัติงานประจำ

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการจัดการความรู้ต่อการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเฉพาะ ดังนี้

1. เปรียบเทียบความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้

2. เปรียบเทียบการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ

ประกอบที่บันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ระหว่างก่อนและ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้

สมมติฐานการวิจัย

1. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้

2. หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความรู้ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ได้บันทึกการ พยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มากกว่า ก่อนเข้าร่วม โปรแกรมการจัดการความรู้

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ กลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพที่กำลังปฏิบัติงาน โดยตรงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพานทอง จำนวน 98 คน

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ที่อยู่ประจำในโรงพยาบาลพานทองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คำนวณโดยใช้โปรแกรม G*Power (Faul et al., 2007) กำหนดค่าความแม่นยำ (d) = 10-15 % กำหนดระดับนัยสำคัญ .05 (สุยงค์ ลวงพิมาย, 2566) ได้ขนาดตัวอย่าง 36 คน

เครื่องมือวิจัย

1. **โปรแกรมการจัดการความรู้** ผู้วิจัยได้ใช้ แนวคิดของกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนของ กระบวนการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและ สำนักงานรัฐมนตรี (ม.ป.ป.) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

1) การกำหนดความรู้/การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและ แสวงหาความรู้ 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4) การ ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การ แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ และการ ส่งเสริมความรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการพยาบาล ผู้ป่วยระดับประคับประคอง ของศรีเวียง ไพโรจน์กุล และปาริชาติ เพียสุพรรณ (2559) ครอบคลุมการจัดกิจกรรมของการ จัดการความรู้สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและชุมชน นักปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยระดับประคับประคอง

2. **แบบวัดความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง** ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประสิทธิภาพการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ ประคอง เป็นแบบเลือกตอบ

ส่วนที่ 2 ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยแบบ ประคับประคอง ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 12 ด้าน ดังนี้

1) การคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่การดูแลแบบประคับประคอง จำนวน 3 ข้อ 2) การประเมินอาการผู้ป่วย (Palliative Performance Scale version 2: PPSv2 (Lau et al., 2009) และ Edmonton Symptom Assessment System: ESAS) จำนวน 4 ข้อ 3) การวางแผนการดูแลและการจัดการอาการ รบกวนจำนวน 3 ข้อ 4) การประเมินและวางแผนการดูแล ใหม่เป็นระยะ จำนวน 2 ข้อ 5) การประเมินปัญหาและ ความต้องการที่ครอบคลุมจำนวน 2 ข้อ 6) การตอบสนอง ความต้องการทั้งด้านจิตสังคมและจิตวิญญาณ จำนวน 2 ข้อ 7) การจัดกิจกรรมส่งเสริมมิติด้านจิตวิญญาณจำนวน 1 ข้อ 8) การให้ข้อมูล/ให้คำปรึกษา จำนวน 3 ข้อ 9) การทำหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของ ชีวิตจำนวน 3 ข้อ 10) การปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนา

เลือกวิธีการศึกษาในช่วงท้ายของชีวิตจำนวน 1 ข้อ 11) การวางแผนจำหน่ายและการเตรียมความพร้อมจำนวน 2 ข้อ และ 12) การดูแลต่อเนื่องในชุมชน จำนวน 3 ข้อ การตอบเป็นแบบ ถูก-ผิด กำหนดคะแนน 1 และ 0 ตามลำดับ

3. แบบประเมินการบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย จำนวน 13 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ประวัติการพยาบาลแบบประทับประคอง ภาวะแทรกซ้อน การประเมินและการรักษาที่ได้รับ เป็นแบบเติมคำ

ส่วนที่ 2 การบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคองในขณะเป็นผู้ป่วย ประกอบด้วย เนื้อหาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคอง 12 ด้าน เป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ กำหนดคะแนนเป็น 1 และ 0 ตามลำดับ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบวัดความรู้การพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคอง ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (index of item-objective congruence [IOC]) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ให้ความคิดเห็นความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.5 – 1.00 และหาความเที่ยงโดยนำไปใช้กับใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน จำนวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง (KR-20) เท่ากับ 0.78

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้รับการรับรองตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข รับรองเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เลขที่โครงการวิจัย CBO Rcc. 66-087 และได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลได้จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยให้สิทธิกลุ่มตัวอย่างในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยลงนาม

ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย และสามารถบอกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ โดยไม่ต้องอธิบาย และไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2567

ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดความรู้การพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคองให้พยาบาลวิชาชีพตอบ เป็นรายบุคคลพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล ให้เวลา 20 นาทีในการตอบ และรับกลับทันทีที่ตอบเสร็จ และนำเวชระเบียนจำนวน 60 แฟ้ม มาประเมินการบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคอง โดยใช้แบบประเมินการบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคองใช้เวลา ประมาณ 7 วัน

ระยะการทดลอง ผู้วิจัยดำเนินการตามโปรแกรมการจัดการความรู้ ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ โดยได้จัดประชุมชี้แจงและนัดหมายพบพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มตัวอย่างทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จัดกิจกรรมจัดการความรู้สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติและชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย ในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 ดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง ใช้เวลา 60 นาที **กำหนดความรู้ ทำการบ่งชี้ความรู้** และจัดทำแผนการจัดการความรู้ร่วมกับพยาบาลวิชาชีพได้ 12 ประเด็น

สัปดาห์ที่ 2 ดำเนินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที ในการแสวงหาความรู้จัดทำเนื้อหาขององค์ความรู้ที่เลือก ค้นหาผู้รู้ที่เกี่ยวข้อง **การสร้างความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้** โดยจัดรวบรวมจัดหมวดหมู่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยแบบประทับประคอง ทำเอกสาร/คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ และ QR Code ให้พยาบาลวิชาชีพได้เข้าถึงความรู้ได้